

- des isodisomie sont des correction de trisomie.

- Mosaïque: si l'anomalie est produite dans la 1^{ère} phase de mitose

- L'avantage de la fish, c'est une technique qui est citée, pas une technique pangénomique ainsi que si on veut chercher à quelque chose on la trouve.

- Pour la mosaïque, on commence par le clone anormal après on passe au clone normal.

- isochromosome: c'est une cassure au sein du centromère après on obtient que les bras long des chromosomes, et pas de bras court.

- syndrome de Down sont caractérisé
* Un retard mental.
* malformation cardiaque.

→ Fragilité chromosomique: un site fragile a faire des cassures chromosomiques

→ Instabilité chromosomique:
* ils sont sans dénaturation
* on ajoute la métacyte C dans un milieu, on doute d'avoir une anomalie.

→ Polymorphisme:

* ce sont des régions de ^{constitutives} Rétérochromatine (il n'y a pas de gène) donc il n'y a pas de conséquence
* Pas de lésion.

* Pas anormales pas pathologique

→ Disomie uniparentale: pas anormale

* ça concerne les chromosomes qui portent des gènes à empreinte parentale

* Proviennent d'une correction d'une monosomie ou une trisomie.

* il y a des maladie qui touche les chromosomes 11 et 15.

→ Translocation réciproque: concerne les chromosomes acrocentriques, ainsi que toutes les types de chromosome.

Translocation réciproque

⊖ équilibrée

⊕ déséquilibrée

⇓
il va y avoir la liaison de 2 chromosomes lors du crossing over ainsi que lors de l'anaphase il va y avoir une séparation rare soit 3 va partir à un pôle et 1 va partir à l'autre ou disversa.

→ Les insertions: cas particuliers de translocation, il y a 3 cas

→ c'est une anomalie accidentelle on peut voir son origine par le CGH. arrêt.

→ des marqueurs chromosomique, ce sont des marqueurs qui sont définie par des petits chromosomes de structure anormale présents en addition aux 46 chromosomes humains connus

→ Aberrations portant sur 2 chromosomes.

* Translocation Robertsoniennes:

seul les chromosomes acrocentrique sont concernée par ce type de translocation, cette translocation Robertsonienne permet de recoller les bras long des chromosomes acrocentrique par

exemple (le 21 avec 15...)

→ un chromosome acrocentrique sont les chromosomes (15, 21, 13, 14, 22)

la translocation augment le risque d'avortement ainsi qu'il augmente la probabilité d'avoir un enfant

Génétique:

→ Inversion:

- Inversion résulte de 2 cassures sur un m chromosome suivi de recollage

- d'inversion paracentrique c'est elle qui cause un danger lors de la gamétogenèse.

- d'inversion péricentrique (lors de la méiose) il faut un appariement allélique ainsi que dans cet appariement il y a un appariement en boucle.

↓
d'extérieur

↓
d'intérieur

↓
gamètes
déséquilibrés

→ Duplication:

↑
mirrored

↑
pendant.

Genétique :

L'anomalie du syndrome de Down

⇓

- il est variable
- sténosis intestinale qui se voit.
- ils ont une malformation cardiaque.
- ils sont plus fragile que les enfants normaux.

- Trisomie 21 :

⇓

- Homogène et libre

- Anomalie de nb donc

il faut réaliser un caryotype pour l'enfant mais non pas au parent.

- elle se manifeste par un problème dans l'homogénéité.

- libre en mosaïque chromosomique

21

- chromosome 21 par translocation récidive.

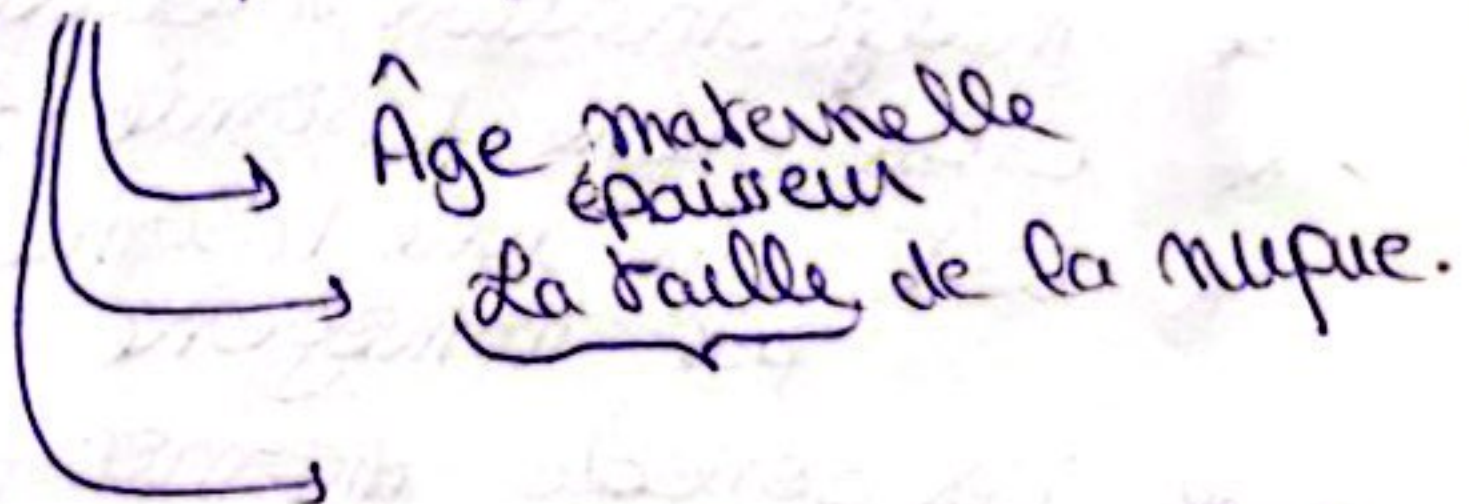
- si c'est une trisomie homogène

L'homme n'est pas fertile par contre
les femmes peut être fertile
(ça veut dire qu'elles peuvent
tomber enceintes) donc 50% des
peuvent être des enfants normaux
et 50% des enfants anormaux.

Translocation Robertsonienne:

↳ Trisomie requise: ~~pour la faire~~
~~il faut faire~~ c'est une correction
de la trisomie 21.

- Diagnostic prénatal de la trisomie 21



- Eustride: eustrogène placentaire
(c'est une protéine fœtale
sécrétée par le foie fœtal)

- Les Bandes des chromosomes
sont claires en G.

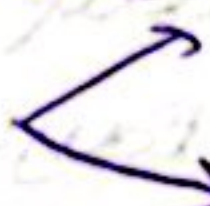
dans leur bras court du chromosome 5
cette perte de ce fragment est due
lors de la méiose.

* Diagnostique p

- syndrome
* est due à une déletion d'une
bande du chromosome 4.

cette déletion a été faite lors
de la méiose.

donc lorsqu'on fait le caryotype
normale donc l'anomalie est
nouvelle.

alors que si le caryotype présente
l'anomalie chez les parents
donc : 
déletion partielle
Trisomie partielle.

- Edward syndrome :

- * viable

- * il y a une grande partie d'enfant qui meurt et il y a aussi ce qui vit

- * Anomalie chromosomique au niveau d'un seul gène

- * Retard mental plus profond

- * malformation au niveau des oreilles et des mains.
(6 doigts)

- Syndrome de Patau :

- * malformation viscérale

- * c'est une trisomie 13 homogène

- * soit par une trisomie libre et pas homogène.

- * ils possèdent chromosome acrocentrique

- * B possède une translocation Robertsonienne entre 2 trisomies 13.

- Syndrome du cri du chat.

- * dysmorphie

- * Retard mental

- * malformation cardiaque

- * lorsqu'on réalise un caryotype on remarque qu'ils ont un problème